SBAR 交接班记录卡

把“发生了什么”与“希望谁来做什么”说清楚

教学示例：病例与数值均为虚构，仅用于表达、记录和讨论练习；不构成院内诊疗规范。请勿填写真实姓名、住院号或上传未脱敏资料。

空白模板

S 现状：我是____，向____交接教学病例____。当前最关注的问题是____，发生/观察时间____。

B 背景：入 ICU 的主要原因____；已知病史____；当前支持____；信息来源及时间____。

A 评估：客观观察____；与前次相比____；自己的判断及依据____；尚不清楚____。

R 请求：请____在____前完成____；复评时间____；接收人复述____；执行结果____。

已填示例 | 虚构病例 A

S：我是轮转医师，交接病例 A。08:00 记录呼吸频率 30 次/分，较 07:00 的 22 次/分增快，请带教老师床旁共同评估。

B：病例 A 因肺部感染相关呼吸困难入科；目前有氧疗记录，但本次设备、流量及记录来源尚需核对。

A：已观察到呼吸频率变化；尚缺同期 SpO2、意识、呼吸做功与氧疗条件，不能只凭单个数值确定原因。

R：由轮转医师补齐同期观察并记录时间，带教老师床旁复核；护士反馈最新监测与设备情况，交接双方复述任务。

练习检查

有没有时间、来源与趋势？是否把事实和判断分开？接收者是否知道下一步任务？“计划复评”不能写成“已完成复评”。

延伸来源：AHRQ | TeamSTEPPS SBAR 沟通工具（2026-11-05 核对）

https://www.ahrq.gov/teamstepps-program/curriculum/communication/tools/sbar.html

机械通气观察与汇报卡

分别记录医嘱/设定、监测读数与床旁观察

教学示例：病例与数值均为虚构，仅用于表达、记录和讨论练习；不构成院内诊疗规范。请勿填写真实姓名、住院号或上传未脱敏资料。

空白模板

教学病例代号____；观察时间____；记录人____；人工气道/通气方式____；患者身高及预测体重资料____。

设定参数及来源：模式____；FiO2____；PEEP____；其余参数____；处方/设备核对时间____。

实际监测：呼出潮气量____；总呼吸频率____；分钟通气量____；气道压力____；报警类型与时间____。

床旁观察：意识/舒适度____；呼吸做功____；同步性____；分泌物____；回路/固定情况____。

关联资料：同期血气及采样时间____；SpO2____；体位/操作变化____；已报告给谁、何时、反馈____。

已填示例 | 虚构病例 B

09:10：设备显示辅助控制模式、FiO2 0.40、PEEP 6 cmH2O；呼出潮气量 420 mL、总频率 24 次/分。此处为记录示范，不表示适合某位患者。

09:15 翻身后出现压力报警。尚无同期波形截图、平台压、患者身高和完整床旁评估，不据此判断通气策略是否合适。

汇报示例：说明报警开始时间、翻身前后变化及当前床旁表现，请有资质人员共同检查并记录处理与复评。

讨论题

哪些是设定，哪些是患者实际表现？缺少哪些资料会影响判断？本卡不自动计算或推荐呼吸机调整。

延伸来源：AARC | 呼吸机相关临床实践指南入口（2026-11-05 核对）

https://www.aarc.org/resource/clinical-practice-guidelines/

病情趋势与循环讨论卡

先画时间线，再讨论依据和信息缺口

教学示例：病例与数值均为虚构，仅用于表达、记录和讨论练习；不构成院内诊疗规范。请勿填写真实姓名、住院号或上传未脱敏资料。

空白模板

主要问题____；观察区间____；基线状态与来源____；当前器官支持____。

时间点 1____：血压/心率____；意识/皮肤灌注____；尿量与统计时长____；乳酸及采样条件____。

时间点 2____：同类指标____；期间事件____；已执行措施与证据____；仅计划但未执行事项____。

讨论：趋势是否可比____；可能解释及支持/反对证据____；缺失信息____；向带教老师提出的问题____。

已填示例 | 虚构病例 C

10:00 记录血压 102/62 mmHg、心率 108 次/分；11:00 记录 92/56 mmHg、心率 118 次/分。测量方式与同一设备使用情况尚需核对。

记录称“拟复查乳酸”，但未见复查结果；不能将其写成“乳酸下降”。尿量记录缺少统计时长，暂不换算趋势。

讨论任务：补齐测量条件、症状与灌注观察、出入量和期间措施，再由带教老师组织鉴别与处理讨论。

复盘问题

是否把相关性写成因果？是否把缺少结果写成正常？每个“改善”或“恶化”有没有对应时间和可比较数据？

原创记录与沟通练习；不提供诊疗结论或处方。

医护协作查房学习卡

围绕每日目标、执行情况与交接闭环分工

教学示例：病例与数值均为虚构，仅用于表达、记录和讨论练习；不构成院内诊疗规范。请勿填写真实姓名、住院号或上传未脱敏资料。

空白模板

疼痛与舒适度：采用的工具____；评估时间/结果____；沟通给谁____。

唤醒与自主呼吸试验相关讨论：今天是否评估适用性____；决定人____；若未进行，原因____。

镇痛镇静相关目标与现状____；谵妄评估工具/结果/无法评估原因____。

活动与康复：今日共同目标____；限制条件____；医师/护士/康复人员分工____。

家属沟通：已授权沟通对象____；关切问题____；已解释内容____；下次沟通安排____。

闭环：事项____；责任人____；完成时点____；执行证据____；未完成原因与后续____。

已填示例 | 虚构病例 D

晨间讨论提出“今天评估活动可行性”，由主管医师和护士共同核对当前支持与限制条件；记录决定和原因。

家属希望了解今天的治疗目标。指定沟通负责人和时间；尚未沟通前，仅写“已安排”，不写“家属已知情”。

本卡用于讨论协作过程。是否实施唤醒、呼吸试验或活动，需由临床团队按患者状态与本院流程决定。

使用方式

参考 SCCM ICU Liberation 学习资源组织讨论。学习卡不是自动执行清单，不替代床旁适用性评估。

延伸来源：SCCM | ICU Liberation 官方学习资源（2026-11-05 核对）

https://www.sccm.org/clinical-resources/iculiberation-home

AKI / CRRT 交班资料采集卡

区分处方、实际治疗与中断记录

教学示例：病例与数值均为虚构，仅用于表达、记录和讨论练习；不构成院内诊疗规范。请勿填写真实姓名、住院号或上传未脱敏资料。

空白模板

肾功能：既往基线及日期____；本次肌酐趋势与时间____；尿量统计起止____；体重依据____。

液体平衡：统计区间____；入量____；出量____；未纳入项目____；记录完整性____。

CRRT 处方：模式____；处方开立时间____；参数及单位____；审核/执行人____。

实际运行：起止时间____；累计运行____；中断起止及原因____；实际净脱水记录____。

通路/滤器/抗凝监测资料____；采样时间及部位____；报警与上报闭环____。

已填示例 | 虚构病例 E

08:00 交班：前班记录 CRRT 于 02:00 至 03:30 中断，原因栏未填写。处方单仍显示原参数，不能直接推算整夜实际治疗量。

练习任务：核对机器运行日志、护理出入量和处方变更记录，补齐中断原因与实际累计数据。

仅有“肌酐升高”且缺少基线与时间序列时，先注明资料不足，不在本练习中自动做 AKI 分期或开出处方。

版本核对

阅读指南时记录正式版/草案、年份与适用人群。2026-11-05 查阅 KDIGO 官网：AKI/AKD 更新仍列为草案审阅后整理阶段；不要将草案标作正式定稿。

延伸来源：KDIGO | AKI / AKD 指南及版本状态（2026-11-05 核对）

https://kdigo.org/guidelines/acute-kidney-injury/

血气与电解质资料整理卡

先核对采样与呼吸条件，再进入分析讨论

教学示例：病例与数值均为虚构，仅用于表达、记录和讨论练习；不构成院内诊疗规范。请勿填写真实姓名、住院号或上传未脱敏资料。

空白模板

标本类型____；采样时间____；采样部位____；报告时间____；异常标本/疑似污染提示____。

采样时氧疗或通气方式____；设备参数____；近期参数/体位改变____；临床状态____。

原始结果与单位：pH____；PaCO2/对应标本气体指标____；PaO2____；HCO3-____；乳酸____；Na/K/Cl____。

对比报告：前次时间____；采样条件是否一致____；其他相关化验____；缺少信息____。

汇报记录：问题____；报告对象/时间____；接收者复述____；复查计划____；实际复查结果____。

已填示例 | 虚构病例 F

报告 1 标注动脉血、09:00；报告 2 标注静脉血、11:00，且呼吸条件记录不全。不能直接把两个氧分压值连成“氧合恶化”的趋势。

练习任务：找出不具可比性的项目，写明需核对的采样条件，形成向带教老师汇报的问题清单。

表达练习

将“血气不好，已处理”改写为：何时、何种标本、哪些结果、当时呼吸条件、向谁报告，以及已执行和待执行的事项。此卡不提供纠正电解质或通气处方。

原创记录与沟通练习；不提供诊疗结论或处方。

病例脱敏与教学投稿卡

保留教学问题，移除身份和可识别细节

教学示例：病例与数值均为虚构，仅用于表达、记录和讨论练习；不构成院内诊疗规范。请勿填写真实姓名、住院号或上传未脱敏资料。

投稿前检查

正文：删除姓名、证件号、住院号、电话、地址及可识别的精确时间线；使用教学代号与相对病日。

附件：检查影像边栏、截图顶部、化验单抬头、文件名、隐藏批注与元数据。罕见情节组合也可能识别个人。

病例使用：按本院管理要求核对授权、审核及适用范围；本平台示例均为虚构，不代表真实患者。

可复制投稿结构

标题：教学问题 + 病例代号。对象：住培/进修/医护共同。病例摘要：主诉、相对时间线与客观观察。

讨论问题：本次需要回答什么？资料有哪些缺口？给出 2-3 个可检验问题。

证据与反馈：官方原始来源、版本、适用人群；带教老师反馈；作者/审核人/复审日期。

已填示例 | 虚构病例 G

标题：交接记录为什么不能只写“病情平稳”？摘要：病例 G 的两次监测相隔 6 小时，缺少中间观察。

问题：哪些描述属于事实，哪些属于判断？资料空档应如何表述？练习答案方向：列出已有观察、明确时间覆盖与缺口，不补造过程。

原创记录与沟通练习；不提供诊疗结论或处方。

PICO 阅读与教学反馈卡

把“看过文献”变成可核对的问题与结论

教学示例：病例与数值均为虚构，仅用于表达、记录和讨论练习；不构成院内诊疗规范。请勿填写真实姓名、住院号或上传未脱敏资料。

阅读模板

P 人群/问题____；I 干预或暴露____；C 对照____；O 关注结局及观察时长____。

题名/作者/年份/DOI或官网____；研究类型____；样本及纳排条件____；主要结局____。

结果记录：效应指标____；置信区间____；绝对风险/原始人数____；不良事件____；未报告项目____。

可信度：偏倚风险____；不确定性____；是否适用本地人群____；与现行制度关系____。

已填示例 | 教学问题，非研究结论

P：ICU 轮转医师；I：结构化 SBAR 交接培训；C：常规入科介绍；O：情景演练中的关键要素完整性。

这只是用于检索和设计讨论的问题，没有提供研究数据，不推断培训效果。可先阅读 AHRQ 的工具定义，再检索原始研究。

带教反馈模板

情景演练：事实/判断分离____；时间与来源____；请求明确____；接收确认____。

逐项记“完整 / 部分 / 缺失”，填写具体例句与下一步练习任务；本示例不设未经验证的及格线。

延伸来源：AHRQ | TeamSTEPPS SBAR 沟通工具（2026-11-05 核对）

https://www.ahrq.gov/teamstepps-program/curriculum/communication/tools/sbar.html